核心精讲

# 腹腔感染

## 性感认识：压痛、反跳痛、肌紧张

### 一、腹膜解剖

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
01:22:35--01:25:19

1.腹膜面积几乎与全身皮肤面积相等（约1.5）

①渗出：腹水

②吸收：强大（盆腹膜相对较差）

③修复：粘连性肠梗阻

「理顺知识点」

- 腹膜炎要尽早处理，避免化学性腹膜炎进展成为化脓性腹膜炎,争取6-8h处理
- 腹膜受刺激会渗出纤维素修复，纤维素未被完全溶解吸收时就会造成粘连，故难预防

2.间皮细胞

①壁腹膜（体神经支配）：定位准确、腹膜刺激征、改变体位时疼痛加剧

②脏腹膜（自主神经支配）

### 二、继发性腹膜炎

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
01:25:19--01:34:55

1.多继发于腹腔空腔脏器穿孔损伤，多为混合性感染（大肠杆菌、厌氧菌多见）

①腹痛：持续剧烈（原发部位最显著）

②标志体征：腹膜刺激征（压痛、反跳痛、肌紧张）

③毒素入血：发热、脉快

④病情恶化：腹胀加重、脉快但体温↓（凉了）、腹水炎细胞↑

「理顺知识点」

- 大多外科疾病：先有局部症状→再有全身症状（吸收入血）
  - 消化性溃疡穿孔：突发上腹刀割样剧痛（局部症状）→毒素大量入血→发热（全身症状）
  - 特殊：急性阑尾炎、急性胆囊炎的腹痛和发热可同时出现
- 大多内科疾病：先有全身症状→再有局部症状
  - 大叶性肺炎：先发热（全身症状）→再有胸痛、腹痛等（局部症状）
  - 特殊：急性心肌梗死：胸痛（局部症状）→心肌细胞坏死→吸收热（全身症状）
- 腹胀越严重→麻痹性肠梗阻越严重→病情越重
- 毒素入血时，机体本应脉快+体温↑，但若患者体温↓，说明病情恶化（感染性休克）
- 腹水内炎细胞才能反映疾病严重程度

2.腹腔穿刺液特点

①草绿色透明液→结核性腹膜炎

②黄色浑浊含胆汁无臭液→胃十二指肠穿孔

③含淀粉酶血性液→急性重型胰腺炎

④稀薄脓性略臭液→急性阑尾炎

⑤臭味重血性液→绞窄性肠梗阻

⑥不凝血→腹腔内出血（多为实质脏器损伤）

「理顺知识点」

- 腹膜有去纤维蛋白作用→不凝血
  - 一般来说：实心脏器出血量大，空腔脏器出血量小

3.治疗

①半卧位：减少毒素吸收、利于引流、利于呼吸循环

②禁食补液、胃肠减压、三代头孢等，休克者需手术探查（右旁正中切口）

「理顺知识点」

- 采用半卧位的原因
  - 毒素积聚在盆腔，由于盆腹膜吸收相对较差，减少毒素吸收入血
  - 液体积聚在盆腔，便于引流
  - 液体积聚在盆腔，避免对膈肌造成压迫，利于呼吸循环
- 继发性腹膜炎多来自阑尾炎、胆囊炎穿孔，而阑尾、胆囊均位于腹腔右侧→右旁正中切口

## 三、原发/自发性腹膜炎

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
01:34:55--01:36:53

①血行播散：多为链球菌（如肺部感染灶经血源性到达腹膜），多见于婴幼儿（血联姻）

②上行性：多为淋球菌，多见于女性

③透壁性：多为大肠杆菌，多见于有腹水的肝硬化（大硬币）

④直接扩散

## 四、腹腔脓肿

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
01:36:53--01:42:49

1.膈下脓肿（负压）

①发热、上腹痛、呃逆、膈肌抬高、胸膜炎

②首选B超

「理顺知识点」

- 远离膈肌的原发灶也可引起膈下脓肿，因为肝脏周围为负压，可吸引液体气体聚集
- 膈下脓肿 vs 肝脓肿：都会发热、上腹痛、肝脓肿扩散时也可出现胸膜炎用辅助检查鉴别

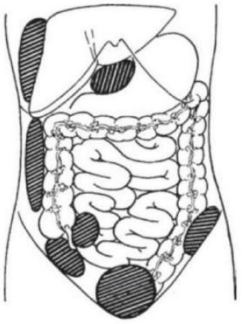


图 37-1　腹腔脓肿好发部位

2.盆腔脓肿

①多继发于阑尾炎、腹盆腔手术后

②发热、肛门下坠感、直肠刺激征（里急后重）和/或膀胱刺激征（尿频尿急尿痛）

③首选直肠指检：直肠前壁有触痛的波动性肿块

④直肠前壁或阴道后穹窿穿刺后切开引流、三代头孢+甲硝唑

## 真题解析·腹腔感染

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
01:42:49--01:43:45

1.2020N59A以下选项中，诊断急性弥漫性腹膜炎最重要的依据是

A.腹痛病史

B.症状和体征

C.B超提示腹腔积液

D.CT见肠管扩张

2.2025N64A下列关于急性阑尾炎穿孔时腹水性状的叙述，正确的是

A.草绿色，透明　结核

B.黄色浑浊，含胆汁　胃十二指肠

C.血性，臭味重　绞窄性肠梗阻

D.稀薄脓性，略臭

　答案：1-2 B D